（二）术后早期并发症

1.**胃瘫** 胃大部切除术切除G细胞(胃泌素↓)-功能性胃运动不良

①类似幽门梗阻但**含胆汁**、**无胃蠕动波** VS 幽门梗阻:无胆汁、有胃蠕动波

②**禁止手术**。可用胃复安、红霉素、新斯的明、糖皮质激素（未付新的红糖）

抑制胆碱酯酶　利用副作用促进胃运动　减轻水肿

让胃运动太强的药反而不能用,可能使患者出现疼痛或吻合口漏

2.出血

1 天内→术中止血不确切（你搞的）

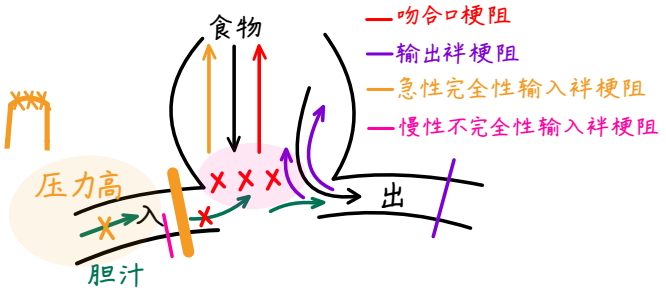
1 周内→吻合口粘膜坏死脱落（新陈代谢-周星驰）

1 月内→吻合口感染腐蚀血管

①胃肠道腔内出血：肠鸣音↑，内镜确诊

②腹腔内出血：肠鸣音↓，腹腔穿刺抽出不凝血确诊

腹膜去纤维蛋白作用



3.胃肠壁缺血坏死、吻合口漏或破裂：多在术后 1 周内

4.十二指肠残端漏或破裂 **梗阻压力高**

①多在术后 1-2 天内，突发上腹痛、腹膜炎，腹腔穿刺可抽出胆汁 类似穿孔

②**急诊修补**、十二指肠造瘘、腹腔引流，若因输入袢梗阻所致需同时解除梗阻

减轻十二指肠的压力

小凯笔记自行整理

呕吐后腹痛不缓解:

①碱性反流性胃炎

②急性胰腺炎

③急性完全性输入袢梗阻

5.梗阻 VS 外科-肠梗阻:遇到肠绞窄直接上手术,不用等到出现腹膜炎再手术

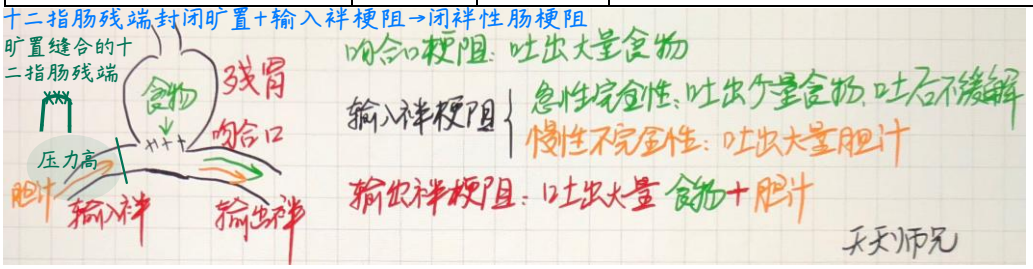
注意：出现肠绞窄（腹膜炎）→手术，否则先保守治疗、无效再手术

食物可以正常流走,但是压力高所以呕吐物会有食物

	食物	胆汁	↑ 其它
急性完全性输**入**袢梗阻	√	×	呕吐频繁、少量食物、**呕吐后不缓解**，**闭袢**性梗阻易肠绞窄
慢性不完全性输**入**袢梗阻	正常×流走	√	呕吐大量胆汁、进食**半小时**左右明显
输**出**袢梗阻	√	√	
吻合口梗阻	√	×	

压力高未缓解　胆汁分泌旺盛

十二指肠残端封闭旷置+输入袢梗阻→闭袢性肠梗阻





慢性不完全性输入袢梗阻:没有完全堵死,胆汁可流下,但流速慢(不完全梗阻),容易在局部积聚,尤其进食半小时胆汁分泌最旺盛

（三）术后远期并发症（亲姐爱杨洋）吻合口太大倾倒综合征 太小导致排空障碍

1.**倾倒综合征**早期倾倒综合征也是远期并发症

早期（进食后 30 分钟）	**晚期**（进食后 2-4 小时）
高渗性胃内容物短时间进入肠道,促进肠道产生大量血管活性物质 明显扩张血管 **低血压**等血容量不足的表现 e.g吃的很饱后头晕	**餐后低血糖**过多胰岛素未被消耗完
压力高 可呕吐（孕妇早期吐的血容量不足❌）	不伴呕吐（孕妇晚期适应了不吐、但被孩子吃了糖）

糖排空最快,脂肪排空最慢

二者都有交感神经兴奋的表现:心悸出汗

鉴别:发生时间、是否呕吐

治疗：低糖和**高脂**饮食，**生长抑素**

特殊:

一般:低脂饮食

抑制血管活性物质、胰岛素的分泌(全抑制)